



胃肠道和胰腺神经内分泌肿瘤概述

作者: **B. Mark Evers**, MD, Markey Cancer Center, University of Kentucky

Reviewed By **Glenn D. Braunstein**, MD, Cedars-Sinai Medical Center

已审核/已修订 5月 2024

神经内分泌肿瘤是源于神经内分泌细胞的肿瘤，神经内分泌细胞的特征与神经细胞和产生激素的细胞相似。神经内分泌肿瘤很罕见，可在任何产生激素的细胞存在的部位发生。大多数神经内分泌肿瘤发生于消化道或胰腺。一些发生于肺部、生殖系统或泌尿系统。

消化道由口腔、咽喉、食道、胃、小肠、大肠（包括阑尾）、直肠和肛门组成。消化道的功能是摄入食物、分解食物、提取营养物质、将其吸收进身体并排出废物。胃酸和肝脏及胰腺的各种消化分泌物有助于这一过程。

胃肠道神经内分泌肿瘤最常发生于小肠、大肠和阑尾。它们通常生长缓慢，可能分泌影响肠道功能的激素，并且可能是非癌性的（良性），也可能是癌性的（恶性）。

胰腺是位于上腹部的一个器官。胰腺产生消化液（包括酶），并将其分泌至消化道。胰腺包含不同类型的细胞。胰岛细胞产生几种**激素**，包括胰岛素，胰岛素有助于控制血糖。

胰腺神经内分泌肿瘤是源于胰岛细胞的肿瘤。这些肿瘤本身可或不可分泌激素，且可能是癌性的，也可能是非癌性的。

胃肠道和胰腺神经内分泌肿瘤有 2 种类型：

- 功能性
- 非功能性

非功能性肿瘤不分泌激素，也不是癌性的。这些肿瘤可通过阻塞胆道或小肠、使胃肠道出血或形成腹部包块而引起症状。

功能性肿瘤会分泌大量特定激素，从而引起各种综合征或其他身体变化。一些功能性肿瘤是癌性的。可能分泌的激素及其肿瘤类型包括

- 胰岛素（**胰岛素瘤**）
- 胃泌素（**胃泌素瘤**）
- 胰高血糖素（**胰高血糖素瘤**）
- 血管活性肠肽（**血管活性肠肽瘤**）

这些激素的过量分泌也可能发生在一种称为**多发性内分泌肿瘤**的疾病中。

胃肠道和胰腺神经内分泌肿瘤的治疗

- 手术
- 阻断激素效应的药物
- 有时使用化疗

大多数胃肠道和胰腺神经内分泌肿瘤，不管是功能性的还是非功能性的，都通过手术切除治疗。然而，对于一些小的、非功能性肿瘤，医生可能监测它们，而不通过手术切除。

有不能手术切除的功能性肿瘤（因为肿瘤太小或由于患者的其他健康问题，手术风险太高）的患者应接受阻断激素生成或作用的药物（如奥曲肽和兰瑞肽）治疗。这些药物也可能有效减缓非功能性肿瘤患者的肿瘤生长。

癌性肿瘤已扩散（转移）的患者通常接受化疗治疗。